

Razonamiento clínico — Codo

bodyPart: elbow · entry: el_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 11

Entrada alternativa por test del informe

- **cozen** → el_cozen
- **mill** → el_mill
- **phalen** → el_neural_hint
- **tinel** → el_neural_hint

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Codo — árbol maestro Physioguide

id: el_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → ¿neural/cuello? → localización (lateral/medial/posterior) → cluster LET/medial → diferencial. Nunca Cozen = diagnóstico confirmado.

Hipótesis:

- **Enrutar por localización y síntomas neurales** (alta) — Lateral → LET. Medial → golfista ± cubital. Hormigueo → neural/cervical.
→ Continúa en: **el_neural_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Síntomas neurales o cervicales dominantes?

id: el_neural_gate

testId: route-elbow-neural

Descripción: Hormigueo 4.º–5.º + flexión codo → cubital. Cuello + brazo → cervical. Si solo dolor lateral/medial mecánico → localización.

Procedimiento: Enrutado clínico (no test físico).

- **Positivo / Sí:** Hormigueo / cuello dominante → **el_neural_cluster**
- **Negativo / No:** Sin cuadro neural dominante → **el_loc_lateral**

3. [CONCLUSIÓN] Compatible con origen neural / cervical

id: el_neural_cluster

Resumen: Priorizar territorio (mediano vs cubital) y cuello. No forzar LET si tests locales poco familiares.

Hipótesis:

- **Neuropatía cubital / referido cervical** (alta) — Hormigueo o cuello dominantes.
→ Continúa en: **el_neural_hint**

4. [TEST / GATE] ¿Dolor lateral (codo de tenista)?

id: el_loc_lateral

testId: route-elbow-lateral

Descripción: Parte externa + agarre/ratón → LET. Si interna → medial.

Procedimiento: Enrutado por localización.

- **Positivo / Sí:** Epicóndilo lateral / agarre → **el_let_cluster**
- **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **el_loc_medial**

5. [CONCLUSIÓN] Cribado neural de codo/mano

id: el_neural_hint

Resumen: Integrar Phalen/Tinel/flexión de codo según territorio. Ver módulo neural + árbol de muñeca si STC.

Hipótesis:

- **Valorar STC vs cubital vs cervical** (alta) — Según dedos afectados y cuello.
- Nodo terminal (fin de rama).

6. [CONCLUSIÓN] Compatible con epicondialgia lateral (LET)

id: el_let_cluster

Resumen: Cluster: epicóndilo lateral + Cozen/Mill familiar + agarre. No confirmado por un test. Cribar cervical/PIN si hormigueo.

Hipótesis:

- **Tendinopatía extensora / LET** (alta) — Patrón de carga lateral familiar.
- **Referido cervical / PIN** (media) — Si cuello u hormigueo asociados.
- Continúa en: **el_cozen**

7. [TEST / GATE] ¿Dolor medial (codo de golfista)?

id: el_loc_medial

testId: route-elbow-medial

Descripción: Parte interna → epicondialgia medial; cribado cubital.

Procedimiento: Enrutado por localización.

- **Positivo / Sí:** Epicóndilo medial → **el_medial_cluster**
- **Negativo / No:** Posterior / olecranon / otro → **el_posterior_cluster**

8. [TEST / GATE] Test de Cozen

id: el_cozen

testId: cozen

Descripción: Extensión de muñeca resistida con codo extendido y antebrazo en pronación.

Procedimiento: Extensión de muñeca resistida con codo extendido y antebrazo en pronación.

Evidencia: Cluster LET (palpación + carga). Zwerus: evidencia de precisión limitada. No confirma inflamación. Cribado cervical/PIN si hormigueo.

- **Positivo / Sí:** Dolor epicóndilo lateral familiar → **el_let_cluster**
- **Negativo / No:** Cozen no familiar → **el_mill**

9. [CONCLUSIÓN] Compatible con epicondialgia medial (± cubital)

id: el_medial_cluster

Resumen: Dolor medial + flexión muñeca/pronación. Si parestesias 4.º–5.º → túnel cubital coexistente o dominante.

Hipótesis:

- **Epicondialgia medial** (alta) — Carga flexora-pronadora.
- **Neuropatía cubital en el codo** (media) — Hormigueo anular/meñique + flexión codo.
- Continúa en: **el_neural_hint**

10. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología posterior / otro

id: el_posterior_cluster

Resumen: Olecranon: bursitis/trauma. Anterior: bíceps distal si pop + hueco. Sin patrón epicondílico claro.

Hipótesis:

- **Bursitis olecraneana / contusión** (media) — Punta posterior ± hinchazón.
 - **Cuadro inespecífico — ampliar anamnesis** (media) — Revisar trauma, neural, cervical.
- Nudo terminal (fin de rama).

11. [TEST / GATE] Test de Mill

id: el_mill

testId: mill

Descripción: Extensión pasiva de codo con muñeca flexionada y antebrazo pronado.

Procedimiento: Extensión pasiva de codo con muñeca flexionada y antebrazo pronado.

Evidencia: Estiramiento del extensor común. Complemento de Cozen; aislado inespecífico. Cluster, no regla de oro.

→ **Positivo / Sí:** Mill familiar → **el_let_cluster**

→ **Negativo / No:** Mill no familiar → **el_loc_medial**